

(9) Thiazide利尿劑
（當Allopurinol與Thiazide利尿劑併用時，建議應對病人加以留意並小心監測，特別是在有已知腎功能不全或可能有腎功能不全的病人，因為可能會發生對Allopurinol之嚴重過敏反應；雖然已經認定受損的腎功能是成為這種不良反應的原因，但是，Thiazide利尿劑可能會經由降低腎臟排泄而增加血清Oxipurinol濃度，也已被做出提議）。

(10) Probenecid
（Probenecid增加Oxipurinol的尿中排泄；不過，藥物的抗高尿酸血症效應是相加的，併用時增加治療效益已經有所報導）。

(11) Sulfipyrazone
（Allopurinol與Sulfipyrazone的抗高尿酸血症是相加的；併用時增加治療效益已經有所報導）。

(12) 系統性Vidarabine。
（Vidarabine與Allopurinol併用可能會增加神經毒性與其他副作用諸如：貧血、噁心、疼痛以及瘙癢病等的危險，如必需併用時應加以小心）。

(13) Xanthines諸如Aminophylline, Oxtriphylline及Theophylline。
（大劑量〔600 mg / 天〕之Allopurinol與Xanthines〔Dyphylline除外〕併用，可能會降低Theophylline的清除率，造成血清Theophylline濃度增加；當穩定態Theophylline為13 mcg/mL〔72.2 mmole/L〕或更高而且需要每天600 mg的Allopurinol時，血清Theophylline濃度就必須加以監測，且於必要時，Theophylline的劑量，也必須要加以調整）。

6. 實驗數值的改變：以下所列已依據它們的潛在臨床重要性為基礎加以選擇（括弧中為其可能的效應）—未必涵蓋一切，（*為其主要臨床重要性者）：
對於生理學 / 實驗室試驗值—
a. 血清鹼性磷酸鹽酶(Alkaline Phosphatase)活性與血清膽紅素(Bilirubin)濃度以及血清轉胺基酶(Transaminase)活性。
（可能會有指示出肝毒性之活性或濃度的升高，特別是在有先前存在之肝病或腎病的病人）。
b. 血液尿素氮(Blood urea nitrogen, BUN)與血清肌酸酐(Creatinine)（可能會有指示出腎毒性之濃度的升高，特別是在有先前存在之腎病的病人）。

7. 醫療考慮 / 禁忌：
所包括醫療考慮 / 禁忌已依據它們的潛在臨床重要性為基礎加以選擇（括弧中為其理由）—未必涵蓋一切。
當有下列醫療問題存在時，其危險—效益必須加以考慮：
(1) 腎功能不全或有傾向於腎功能改變的任何病患諸如：充血性心臟病、糖尿病、高血壓。
（Oxipurinol可能蓄積；嚴重過敏反應與其他不良效應的危險會增加；劑量減少可能是必要的）。
（腎衰竭的危險可能會增加，特別是當Allopurinol被用於黃瘤疾病或尿酸鹽腎病之次發性高尿酸血症時；當這些病況存在時，腎功能的監測可能特別重要）。

(2) 對Allopurinol有過敏之病史者。

8. 病人監測：
以下所列可能在病人的監測上特別重要（有些病人，其他的試驗可能會是正當的，依其情況而定；*為具主要臨床重要性者）：
(1) 完全血液計數與肝功能測定以及腎功能測定。
（建議在治療期間之定期的期間，特別是在首先的幾個月的期間執行之）。

* (2) 血清尿酸。
（為正確投藥，監測可能是需要的；在男性與停經後婦女之正常上限大約為7mg/100mL〔416 micromoles/L〕，在停經前婦女大約為6mg/100mL〔356 micromoles/L〕，但可能會依病人及實驗室方法而有變異）。

9. 超劑量(overdose)的治療：
(1) 立即停用Allopurinol。
(2) 減低吸收—如已攝取非常大量的量，則洗胃。
(3) 增加排除—雖然Allopurinol與Oxipurinol都是可以透析的，但是，血液透析或腹膜透析在Allopurinol超劑量的處理上尚未確立。
(4) 監測—可能包括觀察病人並治療所觀察到的症狀。
(5) 支持性照護—維持水份。對已知或疑其為意圖超劑量的病人，最好照會精神科醫師會診。

10. 病人諮詢
在提供諮詢時，考慮著重以下所選擇的資訊（*為具主要臨床重要性者）：
(1) 使用本藥之前
* 影響使用的情況，特別是：其他藥物，尤其Coumarin或Indandione衍生物的抗凝血劑、Azathioprine以及Mercaptopurine。
(2) 本藥的正確使用
a. 如有必需，飯後服用，以使胃腸道刺激減至最低。
* b. 依從治療。
在治療期間高量流體的攝取，以及如為鹼化尿液而有開列處方時之依從治療的重要性，藉以協助防止腎石(Kidney stones)。對於慢性痛風病人，為達到最大療效，可能要持續治療好幾個月。
* c. 藥物治療可協助防止，但無法解除急性痛風發作；Allopurinol需要持續與痛風發作所處方的藥物一起服用。
* d. 正確投藥。
遺漏劑量：儘快服用；如果幾乎在下一個劑量的時間，則勿再服用；不要加倍劑量。
* e. 正確貯存。
(3) 使用本藥時的留意事項
a. 治療期間定期訪視醫師以檢查治療進展：可能需要定期的血液測試，以確定治療效果及 / 或副作用的發生。
b. 避免大量飲酒，因為它可能增加尿酸濃度並減低藥物的治療效果。
c. 大量服用維生素C可能會增加腎石生成的潛在性。
* d. 如有皮疹發生或如在皮疹發生的同時，或稍後有流行性感冒樣的症狀（顫慄、發燒、肌痛或噁心或嘔吐）發生時，立即通知醫師，這些症狀可能是嚴重過敏反應的開始。
* e. 如有嗜睡（困倦）發生時要留意。

11. 一般投藥資訊
(1) Allopurinol可在飯後服用，以減輕胃腸道刺激。
(2) 在Allopurinol治療的早期幾個月期間，可能會發生痛風性關節炎之發作頻率的增加。產生急性痛風發作的危險可以先以低劑量的Allopurinol開始治療，再逐漸增加劑量直到達到所需要的效應為止而減低之。同時，在Allopurinol治療前3至6個月，預防性劑量的Colchicine（或如病人不能服用，改用非類固醇類抗發炎劑）之併同使用，是被建議的。
(3) 在Allopurinol的治療期間，甚至併用Colchicine或NSAID的預防治療時，痛風的急性發作仍有可能會發生。當急性發作時，雖然一種適當的抗發炎劑（最好是一種NSAID或一種皮質類固醇〔當可行時最好是經由滑膜內注射〕被用於解除發作，但是，Allopurinol仍必須以相同的劑量持續服用。由於與Colchicine治療劑量相關聯的毒性，所以，Colchicine之用於急性痛風發作的治療，對於以比較好的藥物治療為其禁忌或無效的病人，仍必須要加以保留。)

(4) 每日劑量可以以分割的劑量或當作單一的劑量服用。每一個單一劑量，都必須不得超過300 mg。超出300 mg要求的每日劑量，必須要分割劑量使用。

(5) 為正確給藥，血清尿酸濃度的監測可能是必需的。

(6) 為減少黃嘌呤結石生成的危險，並協助同時接受尿酸藥的病人防止尿酸鹽在腎臟中的沉澱，高量流體的攝取（每天不少於2.5至3公升）以及中性或最好是微鹼性尿液的維持，是被建議的。

(7) 當尿酸的治療改變為Allopurinol治療時，尿酸藥的劑量，就必須要在歷經好幾週的期間中逐漸減低，而Allopurinol的劑量則逐漸增加到血清尿酸濃度之維持所需要的劑量。

(8) 如果有皮疹或有任何不良反應的現象發生時，則建議Allopurinol治療要立刻終止。皮疹可能緊跟著會有更為嚴重過敏反應。在有嚴重反應之後，治療就必須永久終止。不過，在輕度反應之後，可能可以在反應退除以後，再以一個較低的劑量重新開始治療。如果皮疹再度發生，則治療就要永久停止。

(9) 不良反應的治療：
過敏反應—服用Glucorticoids。在嚴重反應之後，延長的服用可能會是需要的。

12. 嚴重皮膚反應—使用Allopurinol曾發生極罕見之嚴重皮膚不良反應，包括毒性皮膚壞死（Lyell's症候群）及史蒂文生氏強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome, SJS)的案例報告，嚴重時甚至危及生命或致死。病患若發生嚴重皮膚症狀時應立即停藥，並尋求其他治療方式。從回溯性研究報告得知，使用Allopurinol引起史蒂文生氏強生症候群 / 毒性表皮溶解症(Stevens-Johnson Syndrome/Toxic Epidermal Necrolysis, SJS/TEN)之嚴重皮膚反應，與人類白血球抗原(Human Leukocyte Antigen, HLA-B*5801)基因有統計學上明顯相關性。史蒂文生氏強生症候群在某些亞洲國家（例如臺灣、馬來西亞、及菲律賓）有較高的發生率（罕見而非極罕見）。臺灣族群帶有HLA-B*5801基因的盛行率比歐洲族群及日本族群較高。在使用Allopurinol治療前，宜考慮檢測是否帶有HLA-B*5801基因。長期使用沒有不良反應的病人不建議基因篩檢，無論是否帶有HLA-B*5801基因，發生史蒂文生氏強生症候群的危險在治療開始之後幾個月最大，基因篩檢並不能取代適當的臨床安全監視及病患處置。許多帶有HLA-B*5801基因的病患以Allopurinol治療時，並未發生SJS/TEN的副作用，如135位以Allopurinol治療六個月並未發生SJS/TEN或其他皮膚過敏反應副作用的臺灣病人中，約有15%帶有HLA-B*5801基因，而未帶有HLA-B*5801基因的病患，無論人種，仍可能發生SJS/TEN的副作用。其他可能造成SJS/TEN的因素，例如Allopurinol使用劑量、服藥順從性、併用藥物、同時罹患其他疾病等，都尚未進行研究。

13. 其他皮膚反應—輕微的皮膚症狀，如：分散的斑點或斑丘疹症狀多為暫時性，不論是治療療程的延續或是劑量減少，這些症狀通常在數天或數星期內自動消失，雖然如此初期的症狀很難區分是屬於較嚴重的或輕微短暫的皮膚反應，病人仍須受監視，當症狀持續惡化時，應考慮立即停藥。從回溯性研究報告中得知，使用Allopurinol引起藥物過敏症候群(Drug Hypersensitivity Syndrome)之皮膚反應（如瀰漫性斑丘疹及脫落性皮膚炎），與人類白血球抗原(Human Leukocyte Antigen, HLA-B*5801)基因在臺灣族群也有明顯相關性。

【副作用】
注意—在痛風性關節炎的Allopurinol治療之開始以後，最普遍的不良效應就是急性痛風發作頻率的暫時性的增加。這樣的反應之發生，可以先以一個低劑量開始治療，然後，再逐漸增加劑量直到得到所需要的效應為止以及由秋水仙素(Colchicine)或一種非類固醇抗發炎劑之預防性劑量的服用而予減低之。
以下所列的副作用 / 不良反應已依據它們的潛在臨床重要性為基礎加以選擇（括弧中為其可能的徵象與徵狀）—未必涵蓋一切：
一、需要醫療照護的副作用 / 不良反應：
1. 發生率較為頻繁者—過敏性皮膚炎（皮疹、蕁麻疹、或搔癢）。
注意—最常發生斑丘狀皮疹；不過，類濕疹的、剝落的、囊泡的或紫斑(purpuric)病的損害以及扁平苔癬也有罕見的報導。皮疹之後可能緊跟著會有通常發生在有腎功能不全的病人及 / 或接受Thiazide利尿劑之病人之非常罕有之更嚴重的過敏反應。普遍化的血管炎、肝毒性及 / 或急性腎衰竭也可能會發生。實驗室研究可能會指示出嗜伊紅血球增多症(Eosinophilia)以及白血球減少症(Leucopenia)或白血球增多症(Leucocytosis)。嚴重的死亡都是歸因於這些反應所致。
2. 發生率稀少者—
(1) 粒狀白血球缺乏症(Agranulocytosis)
（有顫慄或沒有顫慄的發燒、唇上或口中有瘡、潰瘍或白色斑點；咽痛）
(2) 貧血（異常疲倦及 / 或虛弱）
(3) 脈管炎(Angiitis [Vasculitis])，過敏反應
（顫慄、發燒及咽痛；肌痛、疼痛或虛弱；呼吸短促、呼吸困難、胸緊迫或哮喘）
(4) 再生不良性貧血(Aplastic anemia)
（呼吸短促、呼吸困難、胸緊迫及 / 或哮喘，唇上或口中有瘡、潰瘍或白色斑點；腺體腫脹及 / 或疼痛；異常出血或疲勞或虛弱）
(5) 剝落性皮膚炎
（顫慄、發燒、咽痛；肌痛或疼痛；及 / 或有嘔吐或沒有嘔吐之噁心的可能前驅症狀；紅色、變厚及鱗屑狀的皮膚）
(6) 多形性紅斑(Multiforme erythema)
（顫慄、發燒、咽痛；肌痛或疼痛；及 / 或有嘔吐或沒有嘔吐之噁心的可能前驅症狀；口中或唇上有瘡、潰瘍或白色斑點；皮疹或瘡、蕁麻疹及 / 或搔癢）
(7) 肝毒性(Hepatotoxicity)
（上腹區膨脹；黃眼或黃皮膚）
(8) Allopurinol誘發的過敏反應
（緊接於顫慄、發燒或咽痛之前或其同時之初始的皮疹；肌痛或疼痛及 / 或有嘔吐或沒有嘔吐之噁心；繼則為血管炎的徵象與徵狀；肝毒性及 / 或急性腎衰竭）
(9) 指甲鬆落；
(10) 中毒性表皮壞死組織分解(Toxic Epidermal Necrolysis)
（顫慄、發燒及咽痛；肌痛或疼痛；及 / 或有嘔吐或沒有嘔吐之噁心、皮膚潮紅、觸痛、灼熱感或脫皮；紅色或刺激的眼睛）
(11) 末梢神經炎
（手腳麻木、刺痛或無力）
(12) 黃嘌呤腎結石
（血尿、排尿困難或疼痛，下背及 / 或側邊疼痛）
(13) 急性腎衰竭
（尿量突減、臉、手指、足及下肢腫脹、體重快速增加）
(14) Stevens-Johnson症候群(Stevens-Johnson syndrome)
（顫慄、發燒、咽痛；肌痛與疼痛；及 / 或有嘔吐或沒有嘔吐之噁心、口中或唇上有瘡、潰瘍或白色斑點；唇上有出血瘡）
(15) 血小板減少症
（通常沒有症狀；異常出血或瘀血；黑糞、焦油糞；尿中或糞中有血；皮膚上的針尖狀紅色斑點）
(16) 無法解釋的鼻出血。
3. 注意—
(1) Allopurinol治療之開始以後的6星期至6年發生骨髓抑制已有報導。大多數受到影響的病人都都接受可能造成這種反應的其他藥物治療。不過，只單獨接受Allopurinol的病人，影響到一個或一個以上的細胞腺(Cell lines)的骨髓抑制則罕有發生。
(2) 肝毒性可能是過敏性—媒介的(Hypersensitivity-mediated)；肝臟壞死、肉芽腫肝炎及膽汁鬱滯性黃膽都已有報導。
(3) 與Allopurinol治療相關的腎衰竭，在對接受黃瘤疾病或痛風性腎病之次發性高尿酸血症治療的病人以及對本藥經歷過過敏性反應的病人，都已經有所報導。

二、只有在病狀持續或是造成困擾時才需要照護的副作用 / 不良反應：
發生率較不頻繁或稀少者—
腹瀉、噁脹、頭痛、消化不良；沒有皮疹、顫慄或發燒或肌痛及疼痛症狀的噁心或嘔吐；胃痛；異常頭髮掉落。

【保存上之注意】
1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】
4~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。



永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號
電話：（04）26875100
台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號



2140080

